

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Richelieu-Salaberry

Dossier : 657822-62C-1802

Dossier CNESST : 141873356

Salaberry-de-Valleyfield, le 6 septembre 2018

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Sonia Sylvestre

Uniformes Premier Choix
Partie demanderesse

DÉCISION

APERÇU

[1] Un travailleur d'Uniformes Premier Choix, l'employeur, subit un accident du travail le 19 novembre 2013 en poussant et soulevant un chariot pour le placer dans un camion.

[2] Dans une décision rendue en décembre 2015¹, la Commission des lésions professionnelles déclare que la lésion professionnelle est une entorse lombaire, qu'elle est consolidée en date du 2 septembre 2014 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles, que le travailleur est capable de refaire son emploi, que les diagnostics de hernies discales L4-L5 et postéro-centrale L5-S1 ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle et que le travailleur n'a pas droit au paiement d'une provocation discale avec manométrie.

[3] Ultérieurement, l'employeur dépose à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) une demande de partage du coût des prestations en vertu de l'article 329 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies*

¹ Leroux et Uniformes Premier Choix, 2015 QCCLP 6824.

*professionnelles*² (la Loi), dont le refus est confirmé par la Commission en révision le 29 janvier 2018. Cela constitue le litige en l'instance.

[4] Devant le Tribunal administratif du travail (le Tribunal), l'employeur allègue que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle, puisqu'il était porteur d'une petite hernie discale L5-S1 postéro-centrale, ce qui a eu des conséquences sur les traitements et la période de consolidation. Il estime que cela lui donne droit à un partage du coût des prestations de l'ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % à l'ensemble des employeurs.

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d'avis que la preuve ne démontre pas que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

ANALYSE

[6] Un employeur peut demander à la Commission de lui imputer seulement une partie du coût des prestations reliées à un accident du travail, si le travailleur qui en est victime est déjà handicapé au moment de sa survenance, conformément à l'article 329 de la Loi qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

Le travailleur visé au premier alinéa peut, à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition, intervenir devant le Tribunal dans un recours relatif à l'application du présent article.

[7] Selon la jurisprudence, un travailleur déjà handicapé au sens de cette disposition est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences³.

² RLRQ, c. A-3.001.

³ Voir notamment *Municipalité de la Petite-Rivière St-François*, [1999] C.L.P. 779; *Ville de Montréal*, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; *S.T.Q. et Dacosta*, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; *CLSC La Petite Patrie*, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; *Brasserie Labatt ltée*, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J.-L. Rivard; *Centre hospitalier régional du Suroît*, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry; *Créations Morin inc.*, C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie; *Exploitations J.Y.B. Papineau inc.*, 2011 QCCLP 4554.

[8] Ainsi, pour déterminer si l'employeur a droit à l'application de l'article 329 de la Loi, le Tribunal doit évaluer si la preuve prépondérante démontre :

- que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle du 19 novembre 2013; la déficience étant une altération d'une structure ou d'une fonction physiologique, psychologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale⁴;

et

- que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[9] La déficience alléguée en l'instance est la présence d'une petite hernie discale L5-S1 postéro-centrale antérieure à la survenance de la lésion professionnelle. Cette hernie discale est révélée pour la première fois à la suite d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombo-sacrée réalisée le 17 décembre 2013, soit environ un mois après l'événement. Les conclusions du radiologiste concernant la région lombaire se lisent comme suit :

L1-L2, L2-L3, L3-L4 et L4-L5 : Normal

L5-S1 : Toute petite hernie discale postéro-centrale qui déforme très légèrement le contour du disque. Il n'y a pas de signe de compression radiculaire. Pas de sténose spinale ou foraminale. Je ne vois pas d'arthrose facettaire.

Pas de spondylolyse ni de spondylolisthésis.

[10] Pour établir le caractère hors norme de cette condition, l'employeur dépose une opinion sur dossier du docteur Zukor, chirurgien orthopédiste. Celui-ci est d'avis que la condition vue à l'imagerie réalisée seulement un mois après l'événement est suffisamment importante pour être qualifiée de handicap préexistant, car elle ne correspond pas au processus normal de vieillissement pour un travailleur âgé de 32 ans.

[11] Le Tribunal rappelle que, lorsque la déficience alléguée porte sur la présence de changements dégénératifs qui, de par leur nature, sont associés à un phénomène de vieillissement normal, la preuve doit démontrer en quoi ces conditions revêtent un caractère anormal par rapport à la norme biomédicale⁵.

⁴ Toujours selon l'affaire *Municipalité de la Petite-Rivière St-François*, précitée, note 3.

⁵ *Natrel inc.* et *Marché Duchemin & frère enr.*, C.L.P. 123564-61-9909, 9 mai 2000, G. Morin; *Sodexo Canada inc.*, C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[12] À l'appui de ses prétentions voulant que la hernie discale L5-S1 soit associée à des changements dégénératifs hors norme, le docteur Zukor réfère à des passages spécifiques d'articles médicaux⁶ qui traitent des phases d'évolution du processus dégénératif en général et des symptômes qui y sont associés. Il n'est fait aucune distinction ou comparaison des phénomènes dégénératifs selon les divers groupes d'âge. De l'avis du Tribunal, ces articles ne sont d'aucune utilité ou pertinence pour établir en quoi la condition que présente le travailleur dévie de la norme biomédicale et ne correspond pas au processus de vieillissement normal pour un homme de 32 ans.

[13] Le docteur Zukor souligne également que, selon l'étude de *Boden et al.*⁷, la présence d'une hernie discale se retrouve chez seulement 20 % des gens de moins de 60 ans ayant participé à l'étude. Ce faisant, il réfère à une phrase qui se retrouve dans le résumé de cet article. Toutefois, selon la cohorte d'âge du travailleur, soit entre 20 et 39 ans, ce pourcentage serait plus précisément de 21 % selon les données qui se retrouvent au tableau 1 de cette étude.

[14] Est-ce dire que la condition du travailleur dévie de la norme biomédicale?

[15] Depuis quelques années, la jurisprudence reconnaissait qu'un seuil de moins de 25 % constituait une déficience à la norme⁸.

[16] Toutefois, la soussignée constate qu'une tendance à la baisse de ce seuil se dessine à la lumière de la jurisprudence plus récente⁹. C'est ainsi que certains décideurs considèrent qu'une prévalence de 20 % ne peut être considérée hors norme puisque « [...] pour se situer en dehors d'une norme, un élément se doit de se démarquer de la normalité. Il doit donc être atypique, aberrant, irrégulier ou déviant. Dans la mesure où un phénomène peut

⁶ Yann Philippe CHARLES et Jean-Paul STEIB, *La lombalgie*, [s.l.], [s.d.], [En ligne], <http://udsmed.ustrasbg.fr/dumg/IMG/pdf/2013_CHARLES_et_STEIB_LA_LOMBALGIE.pdf> (Date de consultation inconnue).

Andrew P. WHITE, Eric L. GROSSMAN et Alan S. HILIBRAND, chap. 13 : « Clinical Presentation of Disc Degeneration », dans Frank M. PHILLIPS et Carl LAURYSEN, *The Lumbar Intervertebral Disc*, New York, Thieme, 2009, pp. 121-125, [En ligne], <https://www.isass.org/pdf/The_Lumbar_Invertabral_Disc_Chapter_13.pdf> (Date de consultation inconnue).

⁷ Scott D. BODEN *et al.*, « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects : A Prospective Investigation », (1990) 72 *Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume*, pp. 403-408.

⁸ Voir notamment : *Ferme porcine Rely inc.*, C.L.P. 398101-03B-0912, 25 août 2010, L. Collin; *Municipalité de Saint-Stanislas*, 2011 QCCLP 7273; *Emballages Knowlton inc.*, 2013 QCCLP 2831; *Bois de construction Sept-Îles Cartier*, 2014 QCCLP 1412; *WEC Tours Québec inc.*, 2017 QCTAT 1760.

⁹ *Ville de Rivière-Rouge*, 2017 QCTAT 931; *Ville de Matane*, 2017 QCTAT 1764; *Microbrasserie La Memphré inc.*, 2017 QCTAT 2339; *IGA Extra*, 2017 QCTAT 2814; *Rio Tinto Alcan inc. Métal primaire Alcan (Alma)*, 2017 QCTAT 4677; *Université de Montréal*, 2018 QCTAT 901; *Chomedey Deslauriers Ford Lincoln*, 2018 QCTAT 1643; *CHSLD Shermont inc.*, 2018 QCTAT 2079; *Prestige Gabriel St-Jean*, 2018, QCTAT 3304.

être constaté approximativement chez un sujet sur cinq, la soussignée estime qu'il s'agit d'une récurrence commune plutôt que marginale¹⁰ ».

[17] En l'instance, il appert qu'outre le segment L5-S1, tous les autres niveaux du rachis lombaire du travailleur sont rapportés normaux. Quant au segment L5-S1, le radiologiste décrit qu'il s'agit d'une « toute petite » hernie discale qui déforme « très légèrement » le contour du disque. Les termes utilisés par le radiologique sont éloquents et témoignent de changements dégénératifs plutôt modestes.

[18] Considérant la nature de la condition dégénérative en cause, le Tribunal conclut, à la lumière de la jurisprudence récente, que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que cette condition dévie de la norme biomédicale pour un homme de 32 ans.

[19] Qui plus est, même s'il s'agissait d'une déficience, la preuve ne supporte pas les prétentions du docteur Zukor voulant que celle-ci ait eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle. À ce sujet, le docteur Zukor écrit :

[...] Tôt dans le dossier, on parle d'hernie discale sur les rapports médicaux de consultation du médecin traitant, et ce, jusqu'au rapport final. De plus, le médecin traitant a prescrit des infiltrations épidurales et blocs facettaires pour traiter le handicap préexistant.

La preuve est prépondérante à l'effet que le handicap préexistant, bien que non causé par l'accident, était symptomatique en cours de consolidation et a compliqué et prolongé la guérison de la lésion professionnelle d'entorse lombaire et nécessité des traitements par infiltrations.

[...]

[Transcription textuelle]

[20] Sur ce, des commentaires s'imposent.

[21] S'il est vrai que le diagnostic de hernie discale L5-S1 est évoqué rapidement au dossier par certains médecins ayant charge du travailleur, ce ne sont pas tous les médecins traitants qui le retiennent, même postérieurement à l'IRM¹¹.

[22] De plus, les affirmations voulant que « *le médecin traitant a prescrit des infiltrations épidurales et blocs facettaires pour traiter le handicap préexistant* » et que « *le handicap préexistant [...] était symptomatique en cours de consolidation* » ne sont pas soutenues par la preuve prépondérante, voire même qu'elles sont contraires à celle-ci.

¹⁰ Ville de Rivière-Rouge, précitée, note 9.

¹¹ La docteure Allard retient uniquement le seul diagnostic d'entorse lombaire.

[23] Dans sa décision du 18 décembre 2015, la Commission des lésions professionnelles procède à une analyse détaillée de l'ensemble de la preuve médicale. Elle conclut qu'il n'y a pas de relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 postéro-centrale et l'événement, considérant l'absence de signes cliniques et symptômes y correspondant. Plus particulièrement, elle écrit :

[...]

[53] Le tribunal constate donc qu'outre l'absence de hernie à L4-L5 visible à l'IRM du 17 décembre 2013, aucun signe clinique de hernie discale à L5-S1 n'est rapporté par aucun intervenant au dossier.

[54] Pour qu'une hernie discale soit reliée à un événement précis, outre des circonstances factuelles compatibles avec ce diagnostic, la preuve doit démontrer un tableau clinique qui comporte les signes et les symptômes qui y correspondent.

[55] En ce qui concerne plus particulièrement la hernie discale postéro-centrale à L5-S1, elle se manifeste par des signes d'irritation dure-mériens ou des signes d'irritation ou de déficit radiculaire. Or en l'espèce, tous les signes propres à une telle hernie sont négatifs. La hernie discale à L5-S1, révélée à l'IRM du 17 décembre 2013, est sans corrélation clinique, que ce soit de façon contemporaine à l'événement accidentel ou plus tard au cours du suivi médical. Elle ne peut donc être reliée à l'événement accidentel du 19 novembre 2013.

[56] Il est à noter que la docteure Allard, le docteur Tohmé et le membre du Bureau d'évaluation médicale Maurais ne retiennent pas ce diagnostic. Étant absent à l'audience, le travailleur n'a pas apporté d'autre élément de preuve.

[57] Le tribunal conclut donc, à la lumière de la preuve médicale contenue au dossier, que le travailleur n'est pas porteur d'une hernie discale reliée à sa lésion professionnelle du 19 novembre 2013, que ce soit à L4-L5 ou à L5-S1.

[...]

[Nos soulignements]

[24] Ainsi, l'affirmation du docteur Zukor voulant que le handicap préexistant, soit la hernie discale L5-S1, ait été symptomatique en cours d'évolution de la lésion professionnelle est en totale contradiction avec les conclusions retenues par la Commission des lésions professionnelles au terme d'une décision finale et irrévocable, laquelle a un caractère liant.

[25] Par ailleurs, s'il est vrai que des infiltrations épidurales et des blocs facettaires sont des traitements souvent prodigués lors de lésion professionnelle impliquant une composante discale sous-jacente, ce n'est pas ce que la preuve sous-tend en l'instance.

[26] La première épidurale est prescrite par un médecin traitant qui retient les diagnostics d'entorse et de hernie discale L5-S1, sans plus de précision. Ultérieurement, les blocs facettaires et autres épidurales sont prescrits à la suite des conclusions émises par le docteur Jodoin, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, dans un avis rendu en avril 2014.

[27] Or, une lecture de cet avis démontre qu'en aucun temps, le docteur Jodoin ne motive ses recommandations d'avoir recours à des blocs facettaires et/ou infiltrations épidurales par la présence d'une condition personnelle d'origine discale sous-jacente, telle la hernie discale L5-S1. En fait, il ne réfère ni ne fait allusion à cette condition et encore moins ne relève des signes cliniques ou symptômes pouvant y être associés. Donc, selon la preuve dont dispose le Tribunal, il est faux de conclure que les blocs facettaires et infiltrations épidurales ont été prescrits en l'instance pour traiter la hernie discale L5-S1.

[28] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l'employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et qu'il ne peut avoir droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 19 novembre 2013.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la contestation déposée par Uniformes Premier Choix, l'employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le 29 janvier 2018;

DÉCLARE que l'employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 19 novembre 2013.

Sonia Sylvestre

Monsieur Olivier Tremblay
C.M.I. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.
Pour la partie demanderesse